

复旦大学附属中山医院

出院记录

姓名:张建国 性别:男 年龄:61岁 住院号:0637205 入院日期:2026-07-15 出院日期:2026-07-20
科室:心血管内科

入院诊断:冠状动脉粥样硬化性心脏病(不稳定型心绞痛)

主诉:反复心前区闷痛 1 周,活动后加重。

现病史:患者近 1 周反复于活动后出现心前区闷痛,持续 3~5 分钟,休息后可缓解,伴气短,无冷汗、无放射痛,自服硝酸甘油可部分缓解,遂来我院急诊就诊收入院。

既往史:高血压 3 级(很高危)10 余年,规律服用氨氯地平、美托洛尔;2 型糖尿病 8 年,规律服用二甲双胍、达格列净;陈旧性脑梗死病史(2023 年,遗留右侧肢体轻度活动不利);糖尿病肾病(早期)。否认肝炎、结核病史。

过敏史:磺胺类药物(皮疹史);否认食物及其他药物过敏史。

住院经过:入院完善冠脉 CTA 及冠脉造影,提示右冠状动脉中段狭窄约 80%,遂于 2026-07-17 行经皮冠状动脉介入治疗(PCI),于右冠状动脉置入药物洗脱支架 1 枚,手术顺利。围手术期预防性抗感染选用头孢曲松钠(皮试阴性),避开磺胺类药物。术后规律予阿司匹林、氯吡格雷双联抗血小板、阿托伐他汀强化降脂治疗,胸闷症状消失,术中及术后监测血糖血压平稳。

出院诊断:1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病(不稳定型心绞痛,PCI 术后) 2. 高血压 3 级(很高危) 3. 2 型糖尿病 4. 陈旧性脑梗死 5. 糖尿病肾病(早期)

出院医嘱:阿司匹林肠溶片 100mg qd 长期服用;硫酸氢氯吡格雷片 75mg qd,服用 1 年后门诊评估是否停用;阿托伐他汀钙片 20mg qn;继续原降压降糖方案;今后就医请主动告知磺胺类药物用药禁忌;1 个月后心内科门诊复查,监测血脂、肝肾功能;如再发胸闷、气短及时就诊。

医师:陈志强 审核:王海燕

复旦大学附属中山
医院 医疗文书专
用章